

Instructivo de Proceso y Registro GES

Versión 1.0 - Octubre 2022

3. Cáncer Cervicouterino en personas de 15 años y más

Departamento GES, Redes de Alta Complejidad y Líneas Programáticas
Departamento Planificación Presupuestaria y Gestión de la Información

Tabla de Contenido

Introducción	3
1. Aspectos del Problema de Salud	4
2. Extracto del Decreto Vigente n°72/2022	
2.1 Definición	4
2.2 Garantías de acceso	4
2.3 Garantías de oportunidad	4
2.4 Garantía protección financiera	5
3. Proceso de atención	
3.1 Ciclo de atención	7
3.2 Flujograma	9
4. Registro SIGGES	11

Introducción

El presente documento tiene por propósito entregar una herramienta práctica que reúna elementos del proceso de atención, gestión y registro de cada uno de los problemas de salud garantizados bajo la normativa vigente.

El documento consta de los siguientes puntos:

- 1) **Aspectos del problema de Salud:** describe la historia del problema de salud desde su entrada en régimen.
- 2) **Extracto del Decreto vigente:** incluye la definición del problema de salud, las garantías de acceso, de oportunidad y de protección financiera.
- 3) **Proceso de Atención:** corresponde al ciclo de atención que sigue cada paciente GES, según las definiciones y normativas del Ministerio de Salud. Tiene como finalidad guiar la aplicación del decreto y su registro asociado.
- 4) **Hitos de Registro:** detalla los hitos de atención a registrar en el SIGGES de acuerdo a las definiciones del decreto y del proceso de atención, la cual está estructurada según las etapas de atención, las garantías de oportunidad y las intervenciones sanitarias correspondientes a este problema de salud, entregando de esta forma, los principales aspectos requeridos para el registro y posterior análisis y monitoreo de la información relacionada a este problema de salud.

1 Aspectos del Problema de Salud

Este problema de salud entra en vigencia con el Decreto N° 170 del año 2005, garantizando las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. El Decreto N° 72 del año 2022 se incorpora la etapa de intervención sanitaria de etapificación y se diferencia la garantía de oportunidad para el tratamiento de la lesión preinvasora de bajo grado y de alto grado.

2 Extracto del Decreto vigente: Decreto N° 72 del 2022

2.1 Definición

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifestó inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, que se pueden suceder en etapas de displasia leve, moderada y severa. Evolucionan a cáncer in situ (circunscrito a la superficie epitelial) o a cáncer invasor, en que el compromiso traspasa la membrana basal.

2.2 Garantía de Acceso:

Todo beneficiario:

- i. Mayor de 25 años y menor de 65 años tendrá acceso a realización de PAP cada 3 años.
- ii. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iv. Con lesión preinvasora de bajo grado, si hay progresión durante el seguimiento, tendrá acceso a tratamiento.
- v. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, etapificación, tratamiento y seguimiento.
- vi. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

2.3 Garantía de Oportunidad:

Tamizaje

- i. El resultado con informe de examen de PAP para beneficiarios mayores de 25 años y menor de 65 años se entregará dentro de 30 días desde la realización del examen.

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de los 40 días desde la sospecha.

Etapificación

- i. La etapificación se realizará dentro de los 20 días desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento

- i. Para la lesión preinvasora de bajo grado se iniciará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- ii. Para la lesión preinvasora de alto grado se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- iii. Para cáncer invasor se iniciará dentro de 20 días desde la etapificación.
- iv. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

Seguimiento.

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

2.4 Garantía de Protección Financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
3	Cáncer cervicouterino en personas de 15 años y más	Tamizaje	Tamizaje cáncer cervicouterino	Cada vez	11.740	20%	2.350
		Diagnóstico	Sospecha cáncer cervicouterino	Cada vez	2.680	20%	540
			Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor	Cada vez	218.860	20%	43.770
			Confirmación cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	240.840	20%	48.170
			Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	351.090	20%	70.220
		Tratamiento	Atención integral para personas con cáncer	Por tratamiento completo	83.670	20%	16.730
			Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Cada vez	103.820	20%	20.760
			Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE	Cada vez	394.290	20%	78.860

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

			II y NIE III o CIS				
			Tratamiento quirúrgico cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	2.043.530	20%	408.710
			Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.379.280	20%	275.860
			Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.142.940	20%	228.590
			Quimioterapia cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	115.680	20%	23.140
			Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	213.870	20%	42.770
		Seguimiento	Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor	Mensual	21.890	20%	4.380
			Seguimiento cáncer cervicouterino invasor	Mensual	26.470	20%	5.290

3 Proceso de atención

3.1 Ciclo de atención

Frente a un beneficiario de entre 25 a 64 años que durante una consulta o control realizado en cualquier nivel de atención se identifica como “sin examen Papanicolau (PAP) **vigente**” (dentro de los últimos 3 años), debe recibir la indicación de realizarse el examen; el profesional matron (a) o el médico, crea el caso en hoja diaria, (si es en APS) iniciando la garantía de tamizaje con un plazo garantizado de 30 días como máximo. Una vez creado el caso y tomada la muestra se registra en SIGGES una Orden de atención (OA) de procesamiento de PAP, que traspasa la garantía al establecimiento de destino. Si el establecimiento de destino es del extrasistema la garantía queda en el establecimiento de origen.

El registro de la prestación PAP, cumple con la garantía de oportunidad del tamizaje. Este registro debe realizarse una vez que el examen se haya procesado, y con la fecha del procesamiento del laboratorio. No corresponde registrar la prestación como realizada, con el hito de la toma de la muestra.

El resultado del examen debe ser informado a la persona independientemente del resultado de éste. Cada establecimiento deberá implementar los mecanismos para asegurar esta acción.

Si el examen informado al paciente resulta normal, corresponde descartar el caso Ges en APS, registrando en Hoja Diaria (HD), cerrando el caso GES.

Con el resultado del PAP alterado, el profesional de APS deberá emitir una solicitud de interconsulta (SIC) derivando a especialista de nivel secundario, lo cual abre la etapa de sospecha diagnóstica, generándose la garantía de confirmación con un plazo máximo de 40 días. De igual manera, si un beneficiario consulta en forma espontánea refiriendo signos y síntomas compatibles o resultados de exámenes relacionados (Virus Papiloma Humano) con este problema de salud, los que son ratificados por el profesional, éste debe emitir una SIC derivando a especialista de nivel secundario como sospecha diagnóstica GES.

El beneficiario que posee PAP alterado realizado previo en el extrasistema y solicita ingreso al GES, deberá acceder a una consulta matrona o médico en APS, en la cual el profesional determinará su derivación a evaluación por especialista de nivel secundario como sospecha diagnóstica.

Para todos estos casos se genera una garantía de confirmación diagnóstica la cual debe ser cumplida en un plazo máximo de 40 días.

Evaluable el beneficiario por el especialista, se confirmará o descartará el problema de salud con un informe de proceso diagnóstico (IPD). En caso de confirmarse, según la etapa de evolución de la patología se le indicará tratamiento o se iniciará estudio de etapificación:

En caso de una lesión preinvasora de bajo grado, el tratamiento se iniciará dentro de 180 días desde la indicación médica, se deberá registrar una OA con la indicación. En la lesión preinvasora de alto

grado, el tratamiento se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica. Para cáncer invasor, el tratamiento se iniciará dentro de 20 días desde la etapificación. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

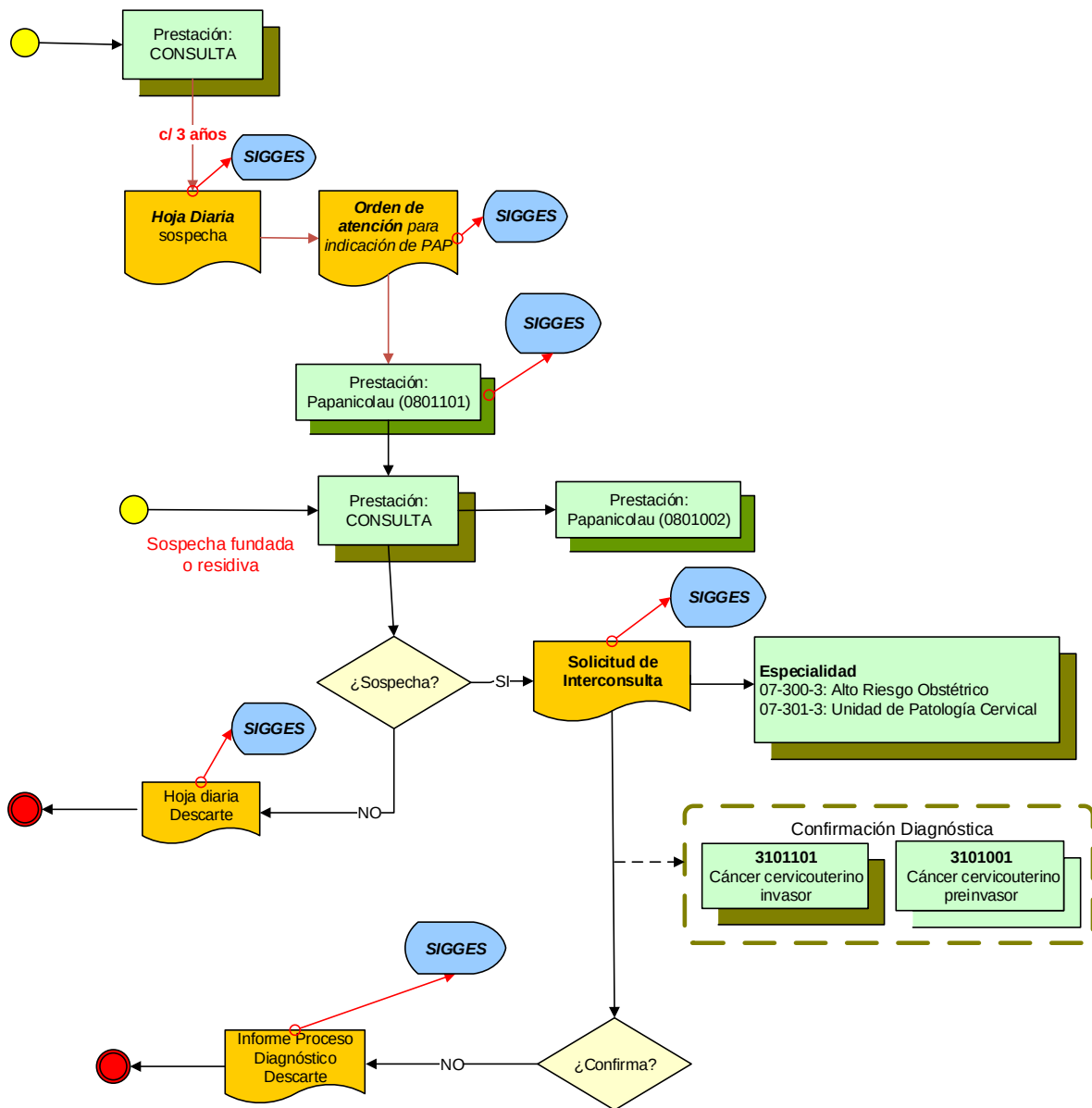
En caso de los pacientes con cáncer cervicouterino que están fuera del alcance terapéutico, el especialista puede indicar la excepción de la garantía de oportunidad correspondiente por criterio de exclusión y posterior derivación a Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos por Cáncer (PS GES n° 4). Se deberá dejar constancia de que se informó al paciente y el profesional tratante responsable de esta indicación deberá dejar registro en la ficha clínica del paciente.

Al finalizar el tratamiento indicado, el profesional tratante debe indicar el control de seguimiento para evaluar la evolución de la paciente, el cual se deberá realizar dentro de 90 días desde la indicación médica.

Si el paciente presenta una recidiva de este problema de salud durante el periodo de seguimiento, entonces el especialista puede indicar nuevamente el tratamiento, considerándolo como un caso GES nuevo.

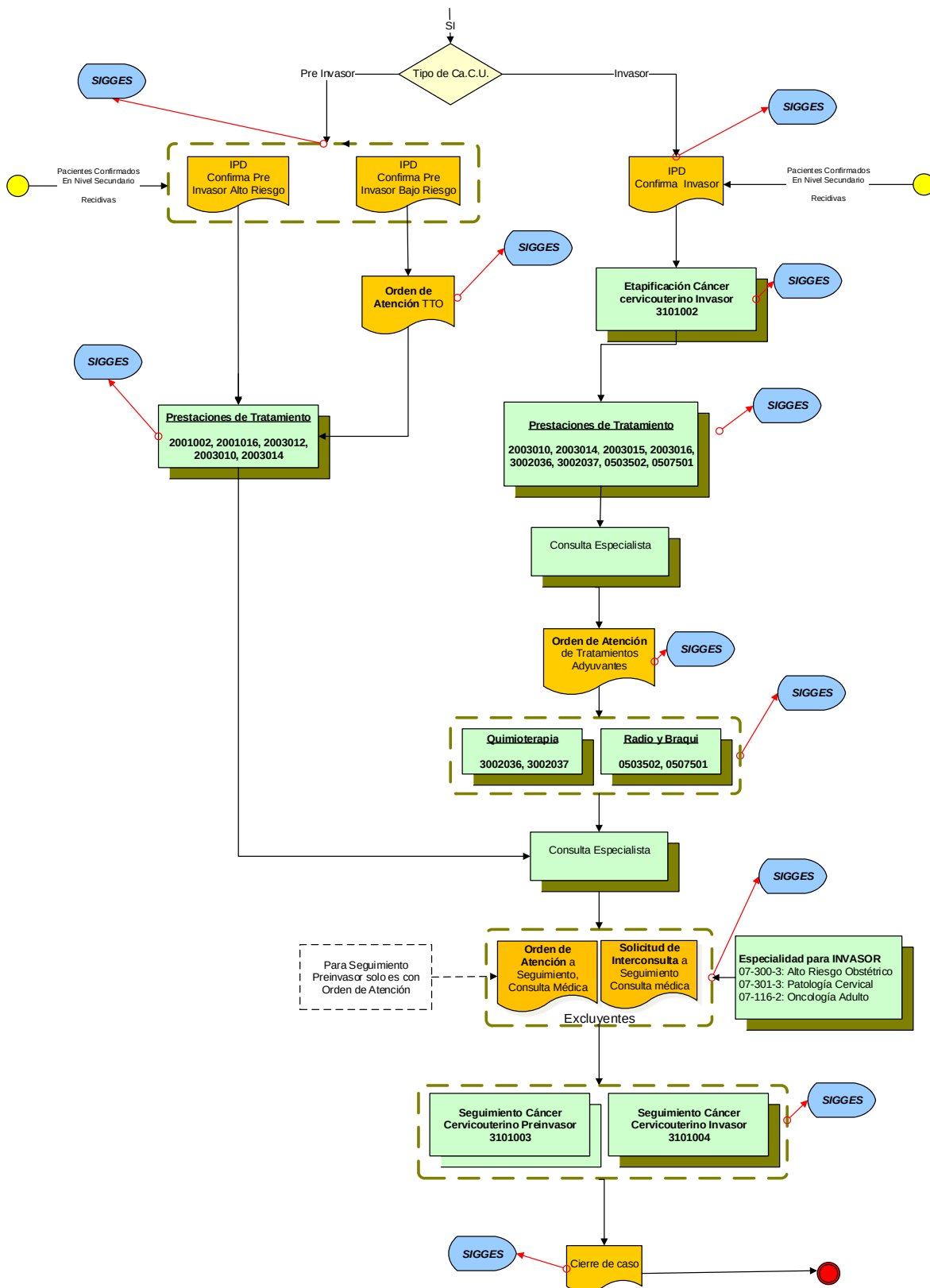
Instructivo de Proceso y registro GES
3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

3.2 Flujograma:



Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años



4 Registro SIGGES

4.1 Tabla Resumen

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Tamizaje	Profesional matrona tamizaje/screening a mujeres de entre 25 y menor de 65 años con PAP	Hoja diaria sospecha (para crear caso)			X		Tamizaje: Examen de PAP dentro de 30 días desde la indicación	Establecimiento que crea el caso hasta que se registre una OA, en ese caso el responsable es el Establecimiento de destino de la OA. Si el establecimiento es extrasistema, entonces es el establecimiento de origen de la OA.	X	
	Laboratorio procesa examen Papanicolau	PO de screening 0801001: Papanicolau	Screening Cáncer Cervicouterino	0801101: Papanicolau (con el examen procesado)			Tamizaje: Examen de PAP dentro de 30 días desde la indicación			X

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Sospecha	Médico o matrona sospecha Cáncer Cervicouterino y deriva a la paciente a especialista Con signos y/o síntomas el Ginecólogo / matrona deriva a especialista	SIC: derivada a distinto de Seguimiento Especialidad: 07-301-3: Patología Cervical 07-300-3: Alto Riesgo Obstétrico 07-116-2: Oncología Adulto	¿???		X		Confirmación Diagnóstica en 40 días desde la sospecha	Establecimiento de destino de la SIC	X	
	En aquellos casos en que se requiere por alguna condición clínica, el médico indica nuevo PAP (no de tamizaje esta vez)		Sospecha Cáncer Cervicouterino	0801102: Papanicolau con el examen procesado) no abre garantía		X				
	En caso de tamizaje negativo (informado a paciente)	HD: descarta Cáncer Cervicouterino			X		Confirmación Diagnóstica en 40 días desde la sospecha			X
Proceso de Diagnóstico	Médico especialista realiza exámenes para determinar el tipo de cáncer y realiza la etapificación si es CaCU Preinvasor / Invasor	PO: Exámenes	Confirmación Cáncer Cervicouterino Preinvasor	3101001: Confirmación Cáncer Cervicouterino Preinvasor		X				X (Sistema Right Now)
			Confirmación Cáncer Cervicouterino Invasor	3101101: Confirmación Cáncer Cervicouterino Invasor		X				X (Sistema Right Now)

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Confirmación	Médico nivel secundario descarta el Cáncer Cervicouterino	IPD: descarta Cáncer Cervicouterino	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica en 40 días desde la sospecha			X
Confirmación	Médico nivel secundario confirma el CaCU como Preinvasor Bajo Riesgo	IPD: Confirma Cáncer Cervicouterino Preinvasor Bajo Riesgo	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica en 40 días desde la sospecha			X
Confirmación	Médico nivel secundario confirma el CaCU como Preinvasor Alto Riesgo	IPD: Confirma Cáncer Cervicouterino Preinvasor Alto Riesgo	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica en 40 días desde la sospecha			X
Confirmación	Médico nivel secundario confirma el CaCU Invasor	IPD: Confirma Cáncer Cervicouterino Invasor	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica en 40 días desde la sospecha			X
Etapificación	Medico indica realización de etapificación en caso de confirmación de CaCU Invasor	IPD: Confirma Cáncer Cervicouterino Invasor	Etapificación		X		Etapificación: dentro de 20 días desde confirmación diagnóstica	Establecimiento que emite el IPD hasta que se registre una SIC en ese caso el responsable es el Establecimiento de destino de la SIC. Si es del extrasistema, entonces es el establecimiento origen de la SIC	X	

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
	Médico indica tratamiento CaCU Invasor	PO: Etapificación	Etapificación	3101002 Etapificación Cáncer cervicouterino Invasor		X	Etapificación: dentro de 20 días desde confirmación diagnóstica			X
Tratamiento Invasor	Médico indica tratamiento CaCU Invasor	OA: derivada a Tratamiento u Otros	Tratamiento Invasor				Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación	Establecimiento destino de la OA. Si es del extrasistema entonces es el establecimiento origen de la OA.	X	
		PO: Tratamiento	Tratamiento Quimioterapia CaCU Invasor	3002036: Tratamiento quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	X	X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Quimioterapia recidiva CaCU Invasor	3002037: Tratamiento quimioterapia recidiva	X	X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Quirúrgico CaCU Invasor	2003010: Histerectomía total o ampliada por vía abdominal; útero y sus elementos de sostén	X	X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Quirúrgico CaCU Invasor	2003014: Histerectomía por vía vaginal	X	X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO: Tratamiento	Tratamiento Quirúrgico CaCU Invasor	2003015: Histerectomía Radical, con disección pelviana completa	X	X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Quirúrgico CaCU Invasor	2003016: Histerectomía total c/intervención incontinencia urinaria, cualquier técnica	X	X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Braquiterapia CaCU Invasor	0503502: Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor		X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Radioterapia CaCU Invasor	0507501: Radioterapia cáncer cervicouterino invasor		X	Tratamiento Invasor: dentro de 20 desde la Etapificación			X
Tratamiento Invasor	Médico indica quimioterapia en CaCU Invasor	OA: derivada a Tratamiento	Tratamiento Quimioterapia CaCU Invasor				Tratamiento Adyuvante Quimioterapia: dentro de 20 desde la indicación médica	Establecimiento destino de la OA. Si es del extrasistema entonces, es el establecimiento origen de la OA.	X	
		PO: Tratamiento Quimioterapia	Tratamiento Quimioterapia CaCU Invasor	3002036: Tratamiento quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	X	X	Tratamiento Adyuvante Quimioterapia: dentro de 20 desde la indicación médica			X

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO: Tratamiento Quimioterapia	Tratamiento Quimioterapia recidiva CaCU Invasor	3002037: Tratamiento quimioterapia recidiva	X	X	Tratamiento Adyuvante Quimioterapia: dentro de 20 desde la indicación médica			X
Tratamiento Invasor	Médico indica radioterapia o braquiterapia en CaCU Invasor	OA: derivada a Tratamiento	Tratamiento Radioterapia y Braquiterapia				Tratamiento Adyuvante Radioterapia y Braquiterapia: dentro de 20 desde la indicación médica	Establecimiento destino de la OA. Si es del extrasistema entonces, es el establecimiento origen de la OA.	X	
		PO: Tratamiento	Tratamiento Braquiterapia CaCU Invasor	0503502: Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor		X	Tratamiento Adyuvante Radioterapia y Braquiterapia: dentro de 20 desde la indicación médica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Radioterapia CaCU Invasor	0507501: Radioterapia cáncer cervicouterino invasor		X	Tratamiento Adyuvante Radioterapia y Braquiterapia: dentro de 20 desde la indicación médica			X
Tratamiento Preinvasor	Médico indica tratamiento CaCU Preinvasor Bajo Riesgo	OA: derivada a Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Bajo Riesgo				Tratamiento Pre-Invasor Bajo Grado: dentro de 180 días desde la indicación médica	Establecimiento destino de la OA. Si es del extrasistema entonces es el establecimiento origen de la OA.	X	

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Bajo Riesgo	2001002: Colposcopia		X	Tratamiento Pre-Invasor Bajo Grado: dentro de 180 días desde la indicación médica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Bajo Riesgo	2001016: Electrodiatermo o criocoagulación de lesiones del cuello		X	Tratamiento Pre-Invasor Bajo Grado: dentro de 180 días desde la indicación médica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Bajo Riesgo	2003012: Conización y/o amputación del cuello, diagnostica y/o terapéutica c/s biopsia		X	Tratamiento Pre-Invasor Bajo Grado: dentro de 180 días desde la indicación médica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Bajo Riesgo	2003010: Histerectomía total o ampliada por vía abdominal; útero y sus elementos de sostén		X	Tratamiento Pre-Invasor Bajo Grado: dentro de 180 días desde la indicación médica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Bajo Riesgo	2003014: Histerectomía por vía vaginal		X	Tratamiento Pre-Invasor Bajo Grado: dentro de 180 días desde la indicación médica			X

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Tratamiento Preinvasor	Médico indica tratamiento CaCU Preinvasor Alto Riesgo	IPD: Confirma Cáncer Cervicouterino Preinvasor Alto Riesgo	Tratamiento Preinvasor Alto Riesgo		X		Tratamiento Pre-Invasor Alto Grado: dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica	Establecimiento que emite el IPD hasta que se registre una SIC en ese caso el responsable es el Establecimiento de destino de la SIC. Si es del extrasistema entonces es el establecimiento origen de la SIC	X	
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Alto Riesgo	2001002: Colposcopia		X	Tratamiento Pre-Invasor Alto Grado: dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Alto Riesgo	2001016: Electrodiatermo o criocoagulación de lesiones del cuello		X	Tratamiento Pre-Invasor Alto Grado: dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Alto Riesgo	2003012: Conización y/o amputación del cuello, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia		X	Tratamiento Pre-Invasor Alto Grado: dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica			X
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Alto Riesgo	2003010: Histerectomía total o ampliada por vía abdominal; útero y sus elementos de sostén		X	Tratamiento Pre-Invasor Alto Grado: dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica			

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO: Tratamiento	Tratamiento Preinvasor Alto Riesgo	2003014: Histerectomía por vía vaginal		X	Tratamiento Pre-Invasor Alto Grado: dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica			X
Seguimiento Preinvasor	Médico indica control a seguimiento al finalizar el tratamiento indicado CaCU Preinvasor	SIC / OA: derivada a Seguimiento Especialidad origen: 07-300-3: Alto riesgo obstétrico 07-116-2: Oncología adulto 07-301-3: Patología cervical	Seguimiento CaCU Preinvasor		X		Seguimiento Pre-Invasor dentro de 90 días desde la indicación médica	Establecimiento destino de la SIC/OA. Si es del extrasistema entonces, es el establecimiento origen de la SIC/OA.	X	
		PO: Seguimiento Especialidad origen: 07-300-3: Alto riesgo obstétrico 07-116-2: Oncología adulto 07-301-3: Patología cervical	Seguimiento CaCU Preinvasor	3101003: Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor		X	Seguimiento Pre-Invasor dentro de 90 días desde la indicación médica			X

Instructivo de Proceso y registro GES

3. Cáncer cervicouterino en personas mayores de 15 años

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Seguimiento Invasor	Médico indica control a seguimiento al finalizar el tratamiento indicado CaCU Invasor	SIC / OA: derivada a Seguimiento Especialidad: 07-300-3: Alto riesgo obstétrico 07-116-2: Oncología adulto 07-301-3: Patología cervical	Seguimiento CaCU Invasor		X		Seguimiento Invasor dentro de 90 días desde la indicación médica	Establecimiento destino de la SIC/OA. Si es del extrasistema entonces, es el establecimiento origen de la SIC/OA.	X	
		PO: Seguimiento Especialidad: 07-300-3: Alto riesgo obstétrico 07-116-2: Oncología adulto 07-301-3: Patología cervical	Seguimiento CaCU Invasor	3101004: Seguimiento cáncer cervicouterino invasor		X	Seguimiento Invasor dentro de 90 días desde la indicación médica			X
Cierre de caso	Médico indica alta al paciente una vez que se termine la etapa de seguimiento, o la paciente presenta reincidencia del cáncer	Formulario de Cierre			X					